

Schizophrénie

Le spectre de la schizophrénie et des autres troubles psychotiques comprend la schizophrénie, les autres troubles psychotiques et la personnalité schizotypique. Ces troubles sont définis par des anomalies dans au moins un des cinq domaines suivants : idées délirantes, hallucinations, pensée désorganisée (discours), comportement moteur grossièrement désorganisé ou anormal (incluant la catatonie) et symptômes négatifs.

Éléments clés qui définissent les troubles psychotiques

Idées délirantes

Croyances fixes qui ne sont pas modifiables à la lumière de preuves contraires. Elles peuvent inclure des idées de persécution, de référence, de grandeur, de contrôle, de transmission de la pensée. Elles sont considérées comme bizarres lorsqu'elles sont manifestement invraisemblables.

Hallucinations

Perceptions sans stimulus externe, présentes dans le contexte d'une conscience claire et non sous le contrôle de la volonté. Elles peuvent concerner toutes les modalités sensorielles, mais les hallucinations auditives sont les plus fréquentes dans la schizophrénie et les troubles apparentés.

Pensée désorganisée (discours)

Inférée à partir du discours du sujet : le sujet peut passer d'un sujet à un autre (déraillement), les réponses peuvent être obliquement liées ou sans rapport avec les questions (tangentialité). Dans les formes graves, le discours peut être incompréhensible (incohérence ou « salade de mots »).

Comportement moteur grossièrement désorganisé ou anormal

Inclut la catatonie : activité motrice réduite ou absente, résistance aux instructions, postures rigides inappropriées, absence de réponses verbales (mutisme et stupeur), mais aussi agitation motrice non influencée par des stimuli extérieurs.

Symptômes négatifs

Comprennent l'aboulie (diminution de la motivation pour des activités auto-initiées), la diminution de l'expression émotionnelle, l'alogie (diminution de la production du discours), l'anhédonie (diminution des capacités à éprouver du plaisir) et l'asociabilité (manque d'intérêt pour les interactions sociales).

Schizophrénie

Critères diagnostiques :

A. Deux (ou plus) parmi les symptômes suivants, chacun devant être présent dans une proportion significative de temps au cours d'une période d'un mois (ou moins en cas de traitement efficace). Au moins l'un des symptômes (1), (2) ou (3) doit être présent :

1. Idées délirantes.
2. Hallucinations.
3. Discours désorganisé (p. ex. incohérences ou déraillements fréquents).
4. Comportement grossièrement désorganisé ou catatonique.
5. Symptômes négatifs (aboulie ou diminution de l'expression émotionnelle).

B. Durant une proportion significative de temps depuis le début du trouble, le niveau de fonctionnement dans un domaine majeur tel que le travail, les relations interpersonnelles ou l'hygiène personnelle est passé d'une façon marquée en dessous du niveau atteint avant le début du trouble (ou, quand le trouble apparaît pendant l'enfance ou l'adolescence, le niveau prévisible de fonctionnement interpersonnel, scolaire ou professionnel n'a pas été atteint).

C. Des signes continus du trouble persistent depuis au moins **6 mois**. Pendant cette période de 6 mois, les symptômes répondant au critère A doivent avoir été présents pendant au moins un mois (ou moins en cas de traitement efficace) ; dans le même laps de temps des symptômes prodromiques ou résiduels peuvent également se rencontrer sous une forme atténuée.

D. Un trouble schizoaffectif, ou dépressif, ou un trouble bipolaire avec manifestations psychotiques ont été exclus parce que : 1) soit il n'y a pas eu d'épisode maniaque ou dépressif caractérisé concurremment avec la phase active des symptômes, 2) soit, si des épisodes de trouble de l'humeur ont été présents pendant la phase active, ils étaient présents seulement pendant une courte période de temps.

E. Le trouble n'est pas imputable aux effets physiologiques d'une substance (p. ex. une drogue donnant lieu à abus, ou un médicament) ou à une autre pathologie médicale.

F. S'il existe des antécédents de trouble du spectre de l'autisme ou de trouble de la communication débutant dans l'enfance, le diagnostic surajouté de schizophrénie est posé seulement si des symptômes hallucinatoires et délirants importants sont aussi présents pendant au moins un mois (ou moins en cas de traitement efficace).

Spécifier si : Avec catatonie — code additionnel 293.89 (F06.1).

Spécifier l'évolution (après un an minimum) : Premier épisode aigu / en rémission partielle / en rémission complète. Épisodes multiples, actuellement aigu / en rémission partielle / complète. Continu. Non spécifié.

Caractéristiques diagnostiques

Les idées délirantes sont présentes chez environ 90 % des personnes souffrant de schizophrénie au cours de leur vie. Les hallucinations, tout particulièrement auditives, sont très fréquentes. Le discours désorganisé reflète la pensée désorganisée caractéristique. Le comportement grossièrement désorganisé peut inclure des difficultés à exécuter des activités de la vie quotidienne.

Les symptômes négatifs rendent compte d'une part substantielle de la morbidité associée à la schizophrénie. L'aboulie se manifeste par une diminution de la motivation pour des activités auto-initiées. Les symptômes négatifs sont habituels dans les phases prodromiques et résiduelles, et peuvent être sévères.

Des symptômes affectifs et de véritables épisodes de trouble de l'humeur sont courants dans la schizophrénie, mais pour différencier la schizophrénie d'un épisode de trouble de l'humeur avec manifestations psychotiques, les épisodes de trouble de l'humeur ne doivent occuper qu'une faible proportion de la durée totale des phases actives et résiduelles de la maladie.

Développement et évolution

L'apparition de la schizophrénie se produit typiquement entre la fin de l'adolescence et le milieu de la trentaine. L'apparition avant l'âge de 17 ans est connue sous le nom de début précoce. Le début peut être abrupt ou insidieux, mais la majorité des sujets présente un développement lent et graduel de signes et de symptômes cliniques divers.

Le cours de la maladie apparaît favorable chez environ **20 %** des personnes souffrant de schizophrénie, et un faible nombre d'entre elles peut récupérer complètement. Cependant, la majorité a toujours besoin de soutien dans la vie quotidienne et beaucoup restent chroniquement malades, avec des exacerbations et des rémissions des symptômes actifs.

Le sexe masculin est associé à un début plus précoce. La phase prodromique est souvent précédée d'une période de quelques semaines à quelques mois de symptômes atténués. Les symptômes cognitifs (mémoire de travail, attention, vitesse de traitement de l'information) peuvent persister quand les autres symptômes sont en rémission et contribuent au handicap de la maladie.

Facteurs de risque et pronostiques

Génétiques et physiologiques

Le risque de schizophrénie est plus élevé en cas d'antécédents familiaux. Les facteurs de risque génétiques identifiés à ce jour sont aussi associés à d'autres troubles mentaux, dont les troubles bipolaires, la dépression et les troubles du spectre de l'autisme. Un risque plus élevé est associé aux complications de la grossesse et néonatales (hypoxie), ainsi qu'à un âge paternel avancé.

Environnementaux

Les événements pathogènes pré et périnataux (stress, infections, malnutrition, diabète maternel) ont été reliés à la schizophrénie. Cependant, la vaste majorité des enfants exposés à ces facteurs de risque ne développe pas de schizophrénie.

Genre

Le sexe masculin est associé à un début plus précoce de la maladie et à un pronostic légèrement moins favorable en moyenne.

Questions diagnostiques liées à la culture

Des facteurs culturels et socioéconomiques doivent être pris en compte, notamment dans les différences de prévalence selon les pays. Une attention particulière doit être portée à l'évaluation du contenu des idées délirantes et des hallucinations en tenant compte du contexte culturel du sujet.

Questions diagnostiques liées au genre

La schizophrénie est légèrement plus fréquente chez les hommes. L'âge de début est plus précoce chez les hommes (début au début de la vingtaine) que chez les femmes (début à la fin de la vingtaine). Les femmes tendent à avoir une meilleure évolution et davantage de symptômes affectifs.

Retentissement fonctionnel

La schizophrénie est associée à des dysfonctionnements significatifs sur les plans social et professionnel. Les progrès scolaires et le maintien d'un emploi sont souvent compromis par l'aboulie et les autres manifestations du trouble, même quand les capacités cognitives sont suffisantes. La plupart des sujets ont un emploi qui se situe à un niveau plus bas que celui de leurs parents, et surtout, en particulier les hommes, ne se marient pas et ont des contacts sociaux limités en dehors de leur famille.

Diagnostic différentiel

Trouble dépressif caractérisé ou bipolaire avec caractéristiques psychotiques. La distinction repose sur la relation temporelle entre les épisodes thymiques et les symptômes psychotiques. Dans la schizophrénie, les symptômes psychotiques sont présents en l'absence d'épisode thymique, ou les épisodes thymiques n'occupent qu'une courte période sur la durée totale de la maladie.

Trouble schizoaffectif. Un épisode thymique est présent simultanément avec les critères de la phase active et pour une durée substantielle de la durée totale de la maladie. Dans la schizophrénie, les symptômes de l'humeur ont une durée relative brève par rapport aux durées des phases active et résiduelle.

Trouble schizophréniforme et trouble psychotique bref. Ils se distinguent par la durée : trouble psychotique bref < 1 mois, trouble schizophréniforme 1–6 mois, schizophrénie ≥ 6 mois.

Trouble délirant. L'absence d'hallucinations importantes, de discours désorganisé, de comportement grossièrement désorganisé ou catatonique et de symptômes négatifs marqués distingue le trouble délirant de la schizophrénie.

Personnalité schizotypique. Le diagnostic de personnalité schizotypique est retenu lorsque les symptômes ne sont pas assez sévères ou persistants pour justifier le diagnostic de schizophrénie.

Trouble du spectre de l'autisme. Le diagnostic surajouté de schizophrénie n'est posé que si des hallucinations et idées délirantes importantes sont présentes pendant au moins un mois.

Substance / affection médicale. Le diagnostic de schizophrénie ne peut être posé que lorsqu'un épisode psychotique est durable et non imputable aux effets physiologiques d'une substance ou à une autre affection médicale.

Comorbidité

Les taux de comorbidité pour les troubles liés à l'usage de substances sont élevés dans la schizophrénie. Le tabac est utilisé à des taux nettement plus élevés que dans la population générale. La comorbidité avec les troubles anxieux est courante. L'évaluation du risque suicidaire est essentielle : environ **5–6 %** des personnes souffrant de schizophrénie meurent par suicide, et environ **20 %** font une tentative de suicide à un moment donné de leur vie. Les comportements suicidaires sont parfois en réponse aux hallucinations commandantes.